Siberkondri ara��t��rma fikirleri

Siberkondri × çocuk gastroenteroloji: açık alanlar ve çalışma fikirleri

Tarih: 12 Ekim 2026. Dayanak: `siberkondri_pediatrik_endoskopi_literatur_raporu.md` + bu tur için ek PubMed sorguları (aşağıda). Etiketler: [kesin] = sorgu/meta veri düzeyinde doğrulandı; [doğrulanmalı] = kontrol edilmedi; [çıkarım] = benim yorumum.

Güç hesabı (α=0.05 iki yönlü, güç 0.80; sandbox'ta hesaplandı):

Hedef etki	Gerekli N
korelasyon r=0.20	194
r=0.25	124
r=0.30	85
r=0.35	62
iki grup, d=0.4	99/kol
iki grup, d=0.5	63/kol
eşleştirilmiş öncesi-sonrası, d=0.3	~88 çift

Bu tur için ek boşluk kontrolleri (PubMed, 12 Ekim 2026):

Sorgu	Sonuç
cyberchondria AND (randomized OR "controlled trial" OR intervention[Title])	10; müdahale olarak yalnız iCBT (Newby 2019, PMID 31739276, CS

Sorgu	Sonuç
	S'deg = 1.09), yaşlılarda farkındalık (Gu2025), bir dijital protokol (

Sorgu	Sonuç
	Malleczek 2026). Ebeveyn/periyoperatif müdahale **0** [kesin]

Sorgu	Sonuç
cyberchondria AND (celiac OR "inflammatory bowel" OR "functional abdominal pain" OR "irritable bowel" OR adherence OR nocebo OR "emergence delirium" OR longitudinal OR "follow-up")	19; pediatrik GİS**0**; boylamsal siberkondri yalnızgenelnüfus (TeP

Sorgu	Sonuç
	oel2016,PMID27497667),gebe(Šoštarić2023,PMID37800057

Sorgu	Sonuç
	0), genç erişkin (Bloch 2025, PMID 41270313) [kesin]
cyberchondria AND (dyadic OR "actor-partner" OR APIM OR "parent-child" OR "mother-child")	**0** [kesin]

Sorgu	Sonuç
("Health Anxiety by Proxy"[tiab] OR HAPYS[tiab] OR CHIRPI[tiab]) AND Turkish/Turkey	**0** [kesin]

Sorgu	Sonuç
(YouTube OR websites OR ChatGPT OR "large language model") AND (endoscopy OR "procedural sedation") AND pediatric AND (quality OR readability)	33; pediatrik GİS endoskopi/sedasyon içeriği **0**; en yakın: pediatrik di

Sorgu	Sonuç
	şsedasyonuLLM(Kocaoğlu2026,PMID41781947)[kesin]

A. Mevcut veri setinden çıkacak ek yayınlar (yeni veri yok)

A1. Aracılık modeli: sürekli kaygı → siberkondri → durumluk kaygı → doz/süre. Erişkin literatürü sürekli kaygı→propofol (Maranets 1999) ve siberkondri→cerrahi korku $R^2 \approx 0.47$ (Polat 2025) diyor; ikisini birleştiren model yok. Senin verinde STAI-2 → CSS → STAI-1 → mg/kg doz yolu test edilebilir (PROCESS/SEM). [çıkarım] Zayıf halka: kesitsel aracılık nedensellik vermez; "keşifsel" diye yaz.

A2. CSS alt boyutları ayrı ayrı. Akgül 2021'de kompulsiyon ve sıkıntı zıt yönde çalıştı. "Hekime güvensizlik" alt boyutu (CSS-33/15'te var, CSS-12'de yok) onam davranışı ve doz tercihiyle ilişkilendirilebilir; kaydettiysen onam süresi, soru sayısı, ret/erteleme ile çapraz tablo. [çıkarım]

A3. Yaş-katmanlı duyarlılık. Çocuk SHAI psikometrisi ≥14 yaşta var (Morales 2013/2016), Türkçe HAI yalnız erişkin (Aydemir 2013). <14 yaş alt grubunu çıkarıp sonuçların dayanıklılığını göster; hakem sorusunu önceden kapat. [kesin + çıkarım]

B. Endoskopi ünitesinde yeni prospektif çalışmalar

B1. Boylamsal ebeveyn siberkondrisi ve endoskopi sonucu. Sevk anı → endoskopi günü → sonuç sonrası 1. ay → 3. ay CSS. Soru: patolojik tanı (çölyak, EoE, İBH) siberkondriyi artırır mı, normal sonuç "güvence" verir mi yoksa aramayı sürdürür mü (Lucock 1997 BMJ'de normal gastroskopi sonrası endişe geri dönüyor, erişkin). Ebeveynde boylamsal CSS **0** [kesin]. Birincil sonlanım: CSS değişimi; ~90 çift (d=0.3). En yüksek yenilik/maliyet oranı. [çıkarım]

B2. Siberkondri → işlem sonrası sağlık hizmeti kullanımı. Yüksek CSS ebeveynlerde 3 ay içinde planlanmamış poliklinik/acil başvurusu, telefon/mesaj sayısı, ek tetkik talebi. Kesitsel acil verisi var (Üstüner Top 2024), prospektif sonlanım yok. Lojistik model; başvuru oranı %20 varsayımıyla ~150–200 aile. [çıkarım]

B3. "Nosebo" hipotezi: ebeveyn siberkondrisi ve çocuğun işlem sonrası semptom/davranış değişikliği. Karami 2026 omurga cerrahisinde siberkondriyi nosebo tetikleyicisi olarak çerçeveliyor; pediatride test edilmedi. Sonlanım: 1., 7., 14. gün çocuk semptom günlüğü (boğaz ağrısı, karın ağrısı, bulantı) + PHBQ-AS. YanYing 2023 ebeveyn anksiyetesi için OR 2.23/3.71 verdi ama CSS ölçmedi. ~124 aile (r=0.25). [kesin boşluk, çıkarım tasarım]

B4. Derlenme kalitesi: PAED/ajitasyon. Ebeveyn CSS/STAI → PAED skoru, derlenme süresi, ebeveynle buluşma sonrası ajitasyon. Ebeveyn anksiyetesi→deliryum için pediatrik kanıt yok (Shebl 2025 MA: erişkinde OR 1.90, pediatride anlamsız); siberkondri→PAED 0 [kesin]. Anestezi ekibiyle ortak. ~99/kol (d=0.4) veya korelasyon 124.

B5. Siberkondri ve onam/karar davranışı. Sedasyon-GA tercihi, onamda soru sayısı, onam süresi, iptal/erteleme, "internette okudum" ifadesi. Diş GA/sedasyonunda sosyal medya tercihi %64.6 etkilemiş (Fidancıoğlu 2026, PMID 41629922); endoskopide yok. Düşük maliyet: onam görüşmesini zamanla, soruları say. [kesin boşluk]

B6. Objektif stres belirteci: ebeveyn tükürük kortizolü + KH. Kara 2019 ve Nouh 2023 çocukta kortizol ölçtü; ebeveynde ölçen endoskopi çalışması bulamadım [doğrulanmalı]. CSS'nin öz-bildirim ötesinde fizyolojik karşılığı var mı? Küçük (n≈60), mekanistik, dergilerin sevdiği tasarım.

C. Ölçek ve metodoloji (alanı temizleyen, çok atıf alan işler)

C1. CHIRPI Türkçe geçerlik. Çocuğa yönelik ebeveyn arama envanteri (Barke & Doering 2020; CSS-15 ile r=0.66). Yalnız Almanca ve Yunanca var; Türkçe 0 [kesin]. ≥300 ebeveyn, DFA, test-tekrar. Senin CSS-15 sorununu da kökten çözer: "vekâleten siberkondri" için doğru araç bu. [çıkarım]

C2. HAPYS Türkçe geçerlik. Vekâleten sağlık anksiyetesi ölçeği (Ingeman 2023, α=0.95). Türkçe 0 [kesin]. C1 ile aynı örneklemde yapılabilir; iki makale.

C3. Türk ebeveynlerde CSS-33/15/12 eşdeğerlik ve anne-baba ölçüm değişmezliği. Powell 2026 bibliometrisi versiyon kaosunu belgeliyor; Türkiye'de kısa formlar madde sayısı bile yazılmadan kullanılıyor (Sarpdağı 2026, Üstüner Top 2024). Tek örneklemde üç formu uygula, bifaktör + çoklu grup DFA. [kesin boşluk]

C4. CIAS (8–15 yaş) Türkçe uyarlama. Çocuk sağlık anksiyetesi için yaşa uygun araç; Türkçe 0 [kesin]. Pediatrik GİS polikliniği + okul örneklemi.

D. Kronik GİS hastalığı popülasyonları (siberkondri + pediatrik GİS: 0 yayın)

D1. Çölyak: tanı sonrası ebeveyn siberkondrisi → glutensiz diyet uyumu. Çölyak sevkinde internet en sık kaynak (%70.6, Tomlin 2014); ebeveynlerin %12'si internet bilgisiyle çocuğun ilacını kesmiş (Ergün Özdel 2025). Sonlanım: 6–12 ayda tTG normalizasyonu + diyet uyum ölçeği; CSS tanı anında. ~85–124 aile. [kesin boşluk]

D2. İBH: ebeveyn + ergen siberkondrisi → tedavi uyumu ve biyolojik tedavi kaygısı. Siberkondri + İBH pediatrik 0 [kesin]. Ergen CSS-12 (≥12 y) + ebeveyn CSS; diyadik model (APIM) — siberkondride APIM 0 [kesin]. Birincil: uyum (MARS/ilaç düzeyi) ve tedavi reddi.

D3. Fonksiyonel karın ağrısı/İBS: ebeveyn siberkondrisi, HAPYS ve çocuğun GİS-özgül anksiyetesi (VSI). Danimarka grubu HAPYS ile ebeveyn-çocuk yolunu gösterdi (Skovslund Nielsen 2025), siberkondri yok; erişkin İBS'de CSS-12 alt boyutları yüksek (Timurkaan 2026). Hipotez: ebeveyn siberkondrisi → semptom izleme davranışı → çocuk ağrı şiddeti. [çıkarım]

D4. Ergenin kendi siberkondrisi GİS kliniğinde. Pediatrik klinikte ergen CSS yalnız PKOS'ta var (Topkara Sucu 2024). Dispepsi/İBS/İBH ergenlerinde CSS-12 + HAI; Teke 2025 (dispepsi, anksiyete bozukluğu %40.7) bağlamı hazır. [kesin boşluk]

E. Müdahale denemeleri

E1. RKÇ: CSS ile taranmış yüksek-siberkondri ebeveynlere hedefli web tabanlı endoskopi/sedasyon bilgilendirme. Web tabanlı bilgi genel ebeveynde STAI'yi düşürüyor (Nytun 2022 SMD −0.66; ağ MA'da web en etkili, SMD −1.40, Priyadarshini 2025). Siberkondri-hedefli perioperatif müdahale 0 [kesin]. Sonlanım: STAI-S, mg/kg propofol, derlenme süresi. ~63–70/kol (d=0.5). Senin kesitsel çalışmanın doğal devamı.

E2. "Reçeteli kaynak" denemesi. Hekim onam sırasında tek güvenilir Türkçe kaynak reçeteler (QR), kontrol standart; sonlanım: işlem gününe kadar arama sıklığı, CSS-sıkıntı alt boyutu, STAI-S. Landier 2017'de broşür internet kullanımını azalttı; Wangler 2020'de aile hekimleri "güvenilir site önerme"yi strateji olarak bildirdi. Küme veya dönüşümlü haftalar tasarımı; ucuz.

F. Dijital içerik ve yapay zekâ

F1. Türkçe "çocuk endoskopi/sedasyon" içerik kalitesi: YouTube/TikTok/Instagram + web. DISCERN, PEMAT, JAMA, okunabilirlik. Pediatrik GİS endoskopi için dünyada 0 [kesin]; pediatrik anestezi ve diş sedasyonunda var. 2–3 ayda biter, tek merkez gerekmez.

F2. LLM yanıtları ebeveyn endoskopi sorularına. 30 sık soru → ChatGPT/Gemini/Claude; doğruluk, DISCERN, okunabilirlik; pediatrik anestezide üç 2026 makale var, endoskopide yok [kesin]. F1 ile birlikte iki makale.

F3. Doğal arama günlüğü. Endoskopi öncesi 7 günde ebeveynin arama geçmişi/ekran süresi (gönüllü dışa aktarım) ↔ CSS ↔ STAI-S. Laboratuvar arama deneyi var (Kubb 2022), doğal ortam verisi bulamadım [doğrulanmalı]. Etik/gizlilik yükü yüksek, yenilik çok yüksek.

G. Nitel ve hekim tarafı

G1. Pediatrik gastroenterolog ve anestezistlerin siberkondrik ebeveynle onam deneyimi. Yalnız Alman aile hekimlerinde nitel çalışma var (Wangler 2020, PMID 32767159); pediatri/anestezi 0. Akdeniz hemşirelik grubunun temellendirilmiş kuram deneyimi (Şenol 2024) yerel işbirliği fırsatı.

G2. Ebeveyn nitel: "endoskopi kararında internet". Karar verme sürecinde arama, güven, hekimle paylaşmama (Ward 2022: yalnız %21 cerrahla konuşmuş). Türkçe 0.

Öncelik sıram [çıkarım]

1. **C1+C2** (CHIRPI/HAPYS Türkçe): hem alan ihtiyacı hem senin ölçek açığını kapatır; hızlı, kesin yayın.
2. **B1** (boylamsal CSS, endoskopi sonucu): en özgün tasarım, orta maliyet.
3. **E1** (hedefli web bilgilendirme RKÇ): doçentlik dosyası için RKÇ değeri.
4. **D1** (çölyak uyumu): klinik anlamı en yüksek, kohortun zaten var.
5. **F1+F2** (içerik/LLM): düşük maliyet, hızlı, iki makale.

Ortak zayıf halka: Türkçe CSS kısa form geçerliği netleşmeden hiçbirinin ölçek bölümü sağlam değil; önce C3 ya da en azından kendi örnekleminde psikometri raporu.